

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA — CONTROL PRENATAL

Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo (sintético) — Consultorio Obstetricia

FILIACIÓN

Nombre:	Lucía Mendoza Quispe (SINTÉTICA - NO REAL)
DNI:	47812936
HC:	HCL-2024-08847
Fecha nacimiento:	15/03/1996
Edad:	28 años
Estado civil:	Conviviente
Ocupación:	Comerciante
Domicilio:	Av. Los Pinos 234, San Juan de Lurigancho, Lima
Fecha consulta:	15/04/2024

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G2 P1. Parto vaginal previo en 2019, RN de 3,200 g sin complicaciones. Lactancia materna 6 meses. Régimen catamenial previo regular.

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES

Personales: niega diabetes, hipertensión, asma. Sin antecedentes quirúrgicos. Familiares: madre con DIABETES MELLITUS TIPO 2 diagnosticada a los 50 años (antecedente relevante para riesgo de diabetes gestacional).

GESTACIÓN ACTUAL

FUR:	27/12/2023
FPP:	03/10/2024
EG actual (por FUR):	16 semanas + 2 días
Embarazo:	Único
Controles prenatales:	2 al momento (incluye éste)

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

Peso actual:	67.5 kg (ganancia 3.5 kg)
Peso pre-gestacional:	64.0 kg
Talla:	1.58 m
IMC pre-gestacional:	25.6 (sobrepeso leve)
PA:	110/70 mmHg
FC:	78 lpm
AU:	14 cm
FCF (Doppler):	152 lpm
Edemas:	Ausentes

LABORATORIOS DEL PRIMER TRIMESTRE (sem 12)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	11.8	g/dL	Dentro de rango
Hematocrito	35.2	%	Normal

Glicemia en ayunas	92	mg/dL	Límite alto-normal
Grupo y factor Rh	O Rh+	—	—
VIH (ELISA)	No reactivo	—	Negativo
VDRL	No reactivo	—	Negativa
HBsAg	No reactivo	—	Negativo
Urocultivo	Negativo	—	Sin crecimiento bacteriano

ECOGRAFÍA DEL PRIMER TRIMESTRE (sem 11+4)

Feto único intrauterino. CCN compatible con edad gestacional 11 semanas 4 días. Latidos fetales presentes y regulares. Translucencia nual dentro de rango. No se evidencian malformaciones estructurales en este momento del desarrollo.

DIAGNÓSTICO

1. Embarazo de 16 semanas + 2 días por FUR. 2. Sobrepeso pre-gestacional (IMC 25.6). 3. Antecedente familiar de DM2 — riesgo aumentado de diabetes gestacional.

PLAN

1. Continuar ácido fólico 5 mg/día y sulfato ferroso 60 mg/día. 2. Educación nutricional básica orientada a control de peso. 3. **PTOG con 75 g en semana 24** por factores de riesgo (sobrepeso + AF de DM2). 4. Próximo control en 4 semanas (semana 20). 5. Signos de alarma instruidos: sangrado, dolor abdominal severo, ausencia de movimientos fetales, edema súbito o cefalea persistente.

Médico tratante: Dr. Juan Carlos Vásquez Torres — CMP 45821

Documento generado para fines de prueba del clinical-extractor de SICA. Sintético. No representa una paciente real.